

PAUSE CARDIO ❤️

Nouveautés de la semaine du 10 octobre 2026

6 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

PRÉVENTION **À connaître** Méta-analyse

Intensive vs Standard Blood Pressure Lowering in People With and Without Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.

JAMA Cardiology · 7 octobre 2026 · Méta-analyse de 27 essais randomisés, 88 830 participants

L'effet d'une baisse intensive de la pression artérielle sur les événements cardiovasculaires et sur le rein restait discuté chez le patient atteint de maladie rénale chronique. Cette méta-analyse de 27 essais randomisés, soit 88 830 participants, a standardisé les résultats selon l'écart de pression systolique obtenu entre les groupes. La baisse intensive réduit les événements cardiovasculaires majeurs de 15 % par 10 mmHg de systolique en moins (RR 0,85 ; IC95 % 0,81–0,89), sans différence selon la présence d'une maladie rénale chronique, et sans augmentation significative du risque d'insuffisance rénale terminale (RR 0,97 ; IC95 % 0,84–1,11). Elle augmente en revanche la fréquence des déclinés soutenus d'au moins 30 % ou 40 % du débit de filtration glomérulaire.

En pratique : la maladie rénale chronique n'est pas une raison de renoncer à une cible tensionnelle basse : le bénéfice cardiovasculaire relatif est le même, et le bénéfice absolu est au moins aussi grand parce que le risque de départ est plus élevé. La baisse intensive s'accompagne plus souvent d'un déclin soutenu du débit de filtration, sans excès significatif d'insuffisance rénale terminale dans ces essais : il faut s'y attendre et le surveiller, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un critère de substitution.

[Article original](#)

PRÉVENTION **À connaître** Recommandations ACC (parcours de décision par consensus d'experts)

Optimizing Blood Pressure Care in Patients With Resistant Hypertension: 2026 ACC Expert Consensus Decision Pathway: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee.

JACC · 5 octobre 2026 · Parcours de décision par consensus d'experts de l'ACC

L'American College of Cardiology publie un parcours de décision par consensus d'experts consacré à l'hypertension résistante, pour combler les lacunes de mise en œuvre laissées par les recommandations 2025 sur l'hypertension. Il s'organise autour de cinq questions : la mesure fiable et reproductible de la pression artérielle, la définition de l'hypertension résistante et sa distinction des autres formes de pression difficile à contrôler, l'approche par étapes (mesures non médicamenteuses, médicaments, dispositifs), l'organisation des équipes de soins pour les patients complexes, et la place des nouvelles technologies. La non-observance est désignée comme un obstacle majeur au contrôle tensionnel, et le document insiste sur une intensification du traitement sans retard, selon les seuils de pression et la réponse du patient.

En pratique : avant de conclure à une hypertension résistante, le parcours fait vérifier la mesure et distinguer la résistance vraie des autres formes de pression difficile à contrôler ; la non-observance y est désignée comme un obstacle majeur. Il propose ensuite une progression ordonnée, des mesures non médicamenteuses aux associations en un seul comprimé et aux dispositifs, avec des soins en équipe et un suivi à distance. C'est un canevas utile pour structurer la consultation du patient dont la pression ne baisse pas, à mettre en regard des recommandations européennes.

[Article original](#)

Biventricular vs conduction system pacing after atrioventricular node ablation for heart failure with atrial fibrillation: the CONDUCT-AF trial.

European Heart Journal · 6 octobre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité, 82 patients

Chez le patient en insuffisance cardiaque avec fibrillation atriale réfractaire, l'ablation du nœud auriculoventriculaire impose une stimulation définitive, classiquement biventriculaire. Dans cet essai mené dans dix centres européens, 82 patients à fraction d'éjection inférieure à 50 % et à QRS fins ont été randomisés entre stimulation du système de conduction (zone de la branche gauche) et stimulation biventriculaire. À 6 mois, la fraction d'éjection s'est améliorée de la même façon dans les deux groupes, de 36 % à 46 % avec la stimulation de conduction et de 34 % à 46 % avec la biventriculaire (différence 0,4 point ; IC95 % -3,1 à 3,8 ; $p = 0,002$ pour la non-infériorité). Avec la stimulation de conduction, le QRS stimulé était plus court, et les temps de procédure et de scopie plus brefs.

En pratique : chez le patient en insuffisance cardiaque à QRS fins dont la fibrillation atriale réfractaire conduit à une ablation du nœud auriculoventriculaire, la stimulation du système de conduction par la zone de la branche gauche est non inférieure à la stimulation biventriculaire sur la récupération de la fraction d'éjection à 6 mois, avec un QRS stimulé plus fin et une procédure plus courte. Elle constitue une option raisonnable dans cette indication, en attendant des données cliniques à plus long terme.

[Article original](#)

Lipid Burden and Efficacy of Preventive PCI of Vulnerable Atherosclerotic Coronary Plaques: Post Hoc Analysis From the PREVENT Trial.

Circulation · 6 octobre 2026 · Analyse post hoc, 598 patients

L'essai PREVENT a montré qu'une angioplastie préventive des plaques vulnérables non significatives sur le plan fonctionnel réduisait les événements cardiaques, sans préciser quelles lésions en tirent le plus de bénéfice. Cette analyse post hoc porte sur les 598 patients qui avaient eu, en plus de l'échographie endocoronaire, une spectroscopie proche infrarouge mesurant la charge lipidique de la plaque. Une plaque riche en lipides était présente chez 37,3 % d'entre eux. Dans ce sous-groupe, l'angioplastie préventive a été associée à moins d'événements que le traitement médical seul (7,3 % contre 17,6 % ; HR ajusté 0,23 ; IC95 % 0,13–0,41), alors qu'aucun bénéfice n'apparaissait pour les plaques pauvres en lipides (5,5 % contre 4,2 % ; HR ajusté 1,00 ; IC95 % 0,54–1,86), avec une interaction significative ($p < 0,001$).

En pratique : cette analyse suggère que le bénéfice de l'angioplastie préventive observé dans PREVENT tient surtout aux plaques riches en lipides, sans bénéfice démontré pour les plaques volumineuses mais pauvres en lipides. Elle ne change pas la pratique courante, où l'angioplastie préventive reste une stratégie en cours d'évaluation, mais elle indique que la composition de la plaque, et pas seulement sa taille, pourrait guider la sélection des lésions dans les futurs essais.

[Article original](#)

Percutaneous coronary intervention using sirolimus-eluting balloons in patients at high bleeding risk: the SELUTION DeNovo HBR substudy.

EuroIntervention · 5 octobre 2026 · Sous-groupe préspecifié, 522 patients

L'essai SELUTION DeNovo a randomisé 3 323 patients entre une stratégie de ballon actif au sirolimus avec stent seulement en cas de besoin et la pose systématique d'un stent actif. Cette sous-étude préspecifiée porte sur les 522 patients à haut risque hémorragique selon les critères ARC-HBR, dont 67 % sont sortis sous anticoagulant oral. À 1 an, la défaillance du vaisseau cible est survenue chez 4,9 % des patients du groupe ballon et 7,9 % du groupe stent (différence absolue -3,05 % ; IC95 % -7,27 à 1,17), les saignements BARC 3 à 5 chez 2,3 % et 3,2 %, et le critère clinique net chez 6,8 % et 10,7 %. Aucune de ces différences n'est statistiquement significative, mais l'arrêt de tout antiagrégant a été plus fréquent dans le groupe ballon, à 30 jours comme à 6 mois.

En pratique : chez le patient à haut risque hémorragique, souvent sous anticoagulant, la stratégie « ballon actif d'abord, stent seulement si nécessaire » n'a pas montré d'excès d'événements ischémiques à 1 an et s'est accompagnée d'arrêts plus fréquents de tout antiagrégant, sans que le traitement antithrombotique ait été protocolisé. C'est un argument de plus en faveur de cette approche chez ces patients, à confirmer par un essai dédié avant d'en faire une règle.

[Article original](#)

Complexity of coronary artery disease in infarct-related cardiogenic shock and multivessel disease: a substudy of the DanGer Shock trial.

EuroIntervention · 5 octobre 2026 · Sous-étude, 256 patients pluritronculaires

Le poids pronostique de l'anatomie coronaire dans le choc cardiogénique compliquant un infarctus restait mal connu : cette sous-étude de l'essai DanGer Shock porte sur les 256 patients pluritronculaires parmi les 355 randomisés, dont 211 avec un score SYNTAX initial disponible. Un score SYNTAX élevé, supérieur à 32, était associé à une mortalité à 180 jours supérieure à celle des scores faibles ou intermédiaires (OR ajusté 3,12 ; IC95 % 1,17–8,69), et le score SYNTAX résiduel prédisait indépendamment la mortalité. L'effet de la pompe à flux microaxial n'était pas modifié par le score SYNTAX (p d'interaction = 0,31). Chez les 35 patients porteurs d'une lésion coupable isolée du tronc commun, la pompe était associée à une mortalité plus faible (OR ajusté 0,17 ; IC95 % 0,03–0,99), signal exploratoire qui ne fait que générer une hypothèse.

En pratique : dans le choc cardiogénique compliquant un infarctus, la complexité coronaire, initiale et résiduelle, est un marqueur pronostique indépendant, mais elle ne permet pas de sélectionner les patients qui bénéficient de l'assistance microaxiale : l'effet de la pompe observé dans DanGer Shock n'a pas varié de façon significative selon le score SYNTAX. Le signal favorable dans l'atteinte isolée du tronc commun mérite une étude dédiée avant toute application.

[Article original](#)